Administratívna a dokumentačná záťaž lekára: koľko času naozaj zaberá, prečo vedie k vyhoreniu a čo z toho platí pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna, nejde o snímku konkrétneho pracoviska. Práca, ktorá v rozvrhu nikde nefiguruje, sa aj tak musí niekde odohrať.

Viditeľná časť práce lekára je vyšetrenie a rozhodnutie. Časť, ktorá rozhoduje o tom, kedy odíde domov, je iná: žiadanky, správy z portálu pacienta, žiadosti o predchádzajúci súhlas poisťovne, obnovy receptov, zápisy a kontroly výsledkov. Je neviditeľná v rozvrhu, nemá vlastný kód výkonu a nevyžaduje prítomnosť pacienta. Práve preto sa dá odložiť, a práve preto sa odkladá na večer.

Prehľadový text, ktorý na tento jav upozornil v októbri 2026 na portáli Medscape, pracuje s pojmom, ktorý si americkí lekári vytvorili sami: *work after clinic*, skratkou WAC, teda práca po ambulancii. Je to presné pomenovanie, lebo nehovorí o nadčase v pracovnoprávnom zmysle. Hovorí o práci, ktorá sa vykonáva po tom, ako sa ambulancia zavrie, a ktorá sa nikde nezapočítava.[1]

Otázka, ktorá rozhoduje o tom, či ide o sťažnosť alebo o doložený problém, znie: dá sa to zmerať? Dá. A merania existujú už desať rokov.

Že nejde o okrajovú nespokojnosť, naznačuje aj prieskum Medscape Insights: sedem z desiatich oslovených lekárov bolo nespokojných s tým, koľko času im zostáva na samotného pacienta, a spokojnosť so zápisom a administratívou hodnotili veľmi nízko, bez očakávania zlepšenia v najbližších piatich rokoch.[2]

Koľko času to naozaj je

Štyri nezávislé práce s odlišnou metodikou dospeli k porovnateľnému obrazu. To je dôležitejšie než ktorékoľvek jednotlivé číslo, pretože každá z metód má inú slabinu, a výsledky sa napriek tomu zbiehajú.

Práca	Metóda	Hlavné zistenie
Sinsky a kol., 2016[9]	Priame pozorovanie (430 hodín, 57 lekárov, 4 odbory) a denníky mimo ordinačných hodín	27,0 % času v ordinačný deň pripadlo na priamy kontakt s pacientom, 49,2 % na dokumentáciu a kancelárske úkony. Na každú hodinu priameho kontaktu teda takmer dve hodiny dokumentácie. Navyše 1 až 2 hodiny každý večer.
Arndt a kol., 2017[4]	Záznamy udalostí z elektronickej dokumentácie (142 lekárov, 3 roky), overené priamym pozorovaním	355 minút (5,9 hodiny) z 11,4-hodinového pracovného dňa v systéme: 269 minút počas ordinačných hodín a 86 minút (1,4 hodiny) po nich. Kancelárske a administratívne úkony tvorili 157 minút (44,2 %), vybavovanie doručenej pošty ďalších 85 minút (23,7 %).
Toscano a kol., 2020[5]	Ekologické momentálne hodnotenie cez aplikáciu v mobilnom telefóne (61 lekárov, 28 pracovísk, 16 štátov)	Po odpočítaní osobného času pripadlo 66,5 % času na priamu starostlivosť o pacienta a 44,9 % celkovo na prácu v elektronickej dokumentácii, z toho 20,7 % výlučne na ňu a 23,6 % súbežne s kontaktom s pacientom.
Rotenstein a kol., 2022[7]	Prevádzkové údaje o čase v systéme (291 lekárov primárnej starostlivosti, rok 2021)	Priemerne 145,9 minúty denne strávených v elektronickej dokumentácii.

Údaje pochádzajú zo Spojených štátov a prevažne z primárnej starostlivosti. Prenositeľnosť absolútnych čísel do slovenskej nefrologickej ambulancie je preto obmedzená. Prenositeľný je však **pomer**: dokumentačná a administratívna zložka tvorí rádovo porovnateľný podiel pracovného dňa ako samotná klinická práca a nezanedbateľná časť z nej sa odohráva po skončení ambulancie.

Čím sa jednotlivé merania navzájom kontrolujú

Priame pozorovanie zachytí všetko, čo sa v ordinácii deje, ale je nákladné, pokrýva málo lekárov a samotná prítomnosť pozorovateľa môže správanie meniť. Záznamy udalostí zo systému pokryjú stovky lekárov a tisíce dní, nezachytia však prácu mimo systému, napríklad telefonát alebo papierovú žiadanku. Hodnotenie cez mobilnú aplikáciu zachytí aj činnosti, ktoré v zázname udalostí nezanechajú stopu, je však založené na sebahodnotení a v citovanej práci výslovne **nedokázalo zmerať prácu doma**, čím podiel práce po ambulancii skôr podhodnocuje.[5]

Arndt a kol. urobili to, čo tento problém čiastočne rieši: údaje zo záznamov udalostí overili priamym pozorovaním a potvrdili ich ako spoľahlivý zdroj informácií o rozvrhnutí času lekára.[4] Práve toto overenie mení „pocit, že administratíva požiera čas“ na doložené zistenie.

Použiteľnosť systémov je merateľná a hodnotenie je zlé

Množstvo času nie je jediná veličina. Rovnako podstatné je, koľko úkonov si jedna úloha vyžiada. Melnick a kol. vyhodnotili v prierezovom prieskume medzi americkými lekármi použiteľnosť elektronickej zdravotnej dokumentácie štandardizovaným nástrojom System Usability Scale, ktorý sa bežne používa naprieč odvetviami.

Priemerné skóre bolo **45,9**, čo je v spodných 9 % spomedzi viac než 1 300 predchádzajúcich hodnotení z iných odvetví a zodpovedá pásmu „neprijateľné“, známkou F. Po úprave na vek, pohlavie, odbor, typ pracoviska, počet odpracovaných hodín a počet nočných pohotovostí sa každý bod lepšieho skóre spájal s o 3 % nižšou pravdepodobnosťou vyhorenia (pomer šancí 0,97; 95 % interval spoľahlivosti 0,97 – 0,98; $p < 0,001$).[6]

Ide o prierezový prieskum s návratnosťou 17,1 %, čo pripúšťa skreslenie výberom aj obrátenú príčinnosť: vyhorený lekár môže ten istý systém hodnotiť horšie. Nález je napriek tomu prakticky použiteľný. Hovorí, že nástroj, s ktorým lekár pracuje polovicu dňa, je používateľsky hodnotený horšie než takmer všetko ostatné, čo kedy niekto takto hodnotil, a že miera tohto hodnotenia sleduje mieru vyhorenia odstupňovane.

Nepohodlné zistenie: viac času v dokumentácii sa spájalo s lepšími ukazovateľmi kvality

Tu sa priamočiary záver „skrátiť čas v systéme“ láme. Rotenstein a kol. spojili prevádzkové údaje o čase

strávenom v elektronickej dokumentácii s ukazovateľmi kvality starostlivosti na úrovni celého zoznamu pacientov jedného lekára. Výsledok bol opačný, než by sa čakalo.

Každých ďalších 15 minút celkového denného času v systéme sa po úprave spájalo s o 0,58 percentuálneho bodu lepšou kontrolou glykovaného hemoglobínu (95 % IS 0,32 – 0,84), o 0,52 bodu lepšou kontrolou hypertenzie (0,33 – 0,71) a o 0,28 bodu vyššou mierou skríningu karcinómu prsníka (0,05 – 0,52). Pri čase venovanom vybavovaniu doručenej pošty boli rozdiely výraznejšie: 2,26 bodu pri glykovanom hemoglobíne, 1,65 bodu pri hypertenzii a 1,26 bodu pri skríningu. Súvislosti sa sústreďovali u lekárov s úväzkom 0,5 a nižším. Pri skríningu diabetu a liečbe dyslipidémie sa žiadna súvislosť nenašla.[7]

Autori to komentujú striedmo a presne: hoci sa dlhší čas v systéme spája s vyhorením, môže zároveň predstavovať mieru dôkladnosti a komunikácie, ktorá niektoré výsledky zlepšuje. Inak povedané, **čas strávený dokumentáciou nie je sám osebe odpad**. Časť z neho je skutočná klinická práca, ktorá sa len odohráva pri klávesnici: kontrola výsledku, odpoveď pacientovi, úprava dávky.

Pre riadenie z toho plynie konkrétne varovanie. Ak si pracovisko určí za cieľ skrátiť čas strávený dokumentáciou, môže spolu s ním skrátiť aj dôkladnosť. Cieľom nemá byť čas, ale **podiel času, ktorý nevyžaduje kvalifikáciu lekára**. Tieto dve veličiny sa dajú ľahko zameniť a ukazovateľ „minúty v systéme“ ich nerozlíši.

Ekonomický rozmer, ktorý rozhoduje o tom, či niekto zasiahne

Argument blahobytom zdravotníkov v rozpočtovom rozhovore spravidla neuspeje. Argument nákladom na náhradu lekára uspeje častejšie.

Americká lekárska asociácia uvádza, že priame náklady organizácie na náhradu jedného lekára sa pohybujú **od 500 000 do viac než 1 milióna amerických dolárov**; odhad zahŕňa nábor, nástupné bonusy, výpadok vykázaných výkonov a zapracovanie nového lekára. K tomu sa pripájajú nepriame náklady: chyby v poskytovaní starostlivosti, vyššie riziko sporu o náhradu škody, nižšia spokojnosť pacientov a poškodenie dobrého mena pracoviska. Náhrada lekára stojí pracovisko spravidla dvoj- až trojnásobok jeho ročnej mzdy.[3]

Tento odhad pochádza z roku 2018, z amerického prostredia a z nominálnych dolárov; priamy prepočet na slovenské pomery možný nie je a číslo tu neslúži ako kalkulácia, ale ako rád veličiny. Ten prenositeľný je: v odbore, kde zapracovanie nefrológa trvá roky a kde v regióne nemusí byť koho osloviť, je cena odchodu jedného lekára neporovnateľne vyššia než náklad na administratívnu podporu, ktorá by jeho odchodu predišla.

Prečo je nefrológia na túto záťaž zvlášť citlivá

Nefrologická ambulancia, dialyzačné stredisko a konziliárna činnosť majú štyri vlastnosti, ktoré dokumentačnú záťaž znásobujú.

1. **Hustota opakovaných rozhodnutí medzi návštevami.** Kaliémia, acidobázická rovnováha, anémia, metabolizmus vápnika a fosforu a krvný tlak sa sledujú priebežne a každá zmena hodnoty si vyžiada rozhodnutie, zápis a oznámenie pacientovi. Veľká časť nefrologickej práce sa nedeje počas návštevy, ale medzi návštevami.
2. **Rozdelenie starostlivosti medzi viaceré pracoviská.** Pacient na dialýze, pacient pripravovaný na transplantáciu aj pacient v predialyzačnej starostlivosti sa pohybujú medzi strediskom, ambulanciou, transplantačným centrom a lôžkovým oddelením. Každé rozhranie vytvára prenos dokumentácie, hlásenie zmien a kontrolu, či informácia dorazila.
3. **Schvaľovacie postupy.** Vybrané lieky, pomôcky a výkony si vyžadujú samostatné zdôvodnenie, doklady a opakovanú komunikáciu s poisťovňou. Táto práca je pre pacienta neviditeľná, pre lekára časovo náročná a pre systém spravidla nehonorovaná.
4. **Dostupnosť mimo ordinačných hodín.** Pacient so zavedeným režimom, jeho rodina aj spolupracujúci lekári sa obracajú na nefrológa s otázkami, ktoré neznesú odklad o týždeň, ale nie sú ani dôvodom na akútne vyšetrenie. Tento tok správ nemá v rozvrhu vlastné miesto, preto si ho nájde vo voľnom čase.

Priame merania záťaže špecificky pre nefrológiu k dispozícii nie sú a uvedené body sú odvodené z povahy odboru, nie z meraní. Ten rozdiel treba priznať.

Čo sa dá urobiť

Nasledujúce kroky majú rôznu mieru doloženosti. Prvý a druhý vyplývajú priamo z citovaných prác, ostatné sú racionálne organizačné opatrenia bez priameho dôkazu o účinnosti v nefrológii.

Najprv zmerať, potom škrtať

Arndt a kol. ukázali, že záznamy udalostí dokážu rozdeliť čas na kategórie a identifikovať úkony, ktoré možno delegovať, čím sa záťaž dá znížiť bez straty obsahu.[4] Bez takého rozdelenia sa záťaž len presúva. Pre nefrologické pracovisko je užitočné vedieť, koľko času padne na vybavovanie správ, na reakcie na laboratórne zmeny, na podklady pre schvaľovanie a na opakované objednávanie, pretože každá z týchto položiek má iné riešenie.

Delegovať úkony, nie zodpovednosť

Časť činností, teda príprava podkladov, koordinácia termínov, štandardizované žiadosti a prvotné triedenie správ, nevyžaduje kvalifikáciu lekára a dá sa v rámci platných kompetencií presunúť na sestru alebo administratívneho pracovníka. Kritérium je jednoduché: vyžaduje tento úkon klinické rozhodnutie? Ak nie, do času lekára nepatrí. Klinická zodpovednosť za rozhodnutie zostáva nedelegovateľná.

Vybavovanie správ urobiť viditeľným procesom

Pokiaľ schránka správ nemá v rozvrhu vlastný čas, vlastné pravidlá triedenia a určenú zodpovednosť, stane sa z nej druhé, neevidované pracovisko. Vyhradené okno na odpovede počas pracovného času, jasné pravidlo, čo rieši sestra a čo lekár, a zrozumiteľná informácia pre pacienta o tom, kedy odpoveď príde, tlak na okamžitú reakciu znižujú. Vzhľadom na zistenie Rotensteina a kol. je namieste opatrnosť: cieľom je odbremeniť lekára od toho, čo robiť nemusí, nie skrátiť čas venovaný odpovediam pacientom.[7]

Štandardizovať zápis tam, kde šetrí úkony

Šablóna má zmysel, ak uberá úkony a znižuje riziko opomenutia. Nemá zmysel, ak len vytvára dlhší text s rovnakým informačným obsahom. Kancelárske a administratívne úkony tvorili v práci Arndta a kol. 44,2 % času stráveného v systéme, čo je zároveň najväčší priestor na zlepšenie aj najväčšie riziko, že sa optimalizáciou stratí podstatná informácia.[4]

Technológiu nasadzovať s vopred určeným cieľom a kontrolou

Nástroje, ktoré znižujú počet manuálnych vstupov, vrátane automatických zapisovačov, majú potenciál uvoľniť čas. Pred nasadením treba vedieť, ktorý konkrétny úkon majú nahradiť, kto a ako overí vecnú správnosť výstupu a čo sa stane s procesom kontroly dokumentácie. Zistenie o zlej použiteľnosti existujúcich systémov je pritom varovaním aj pre nové nástroje: pridaný systém, ktorý sa zle ovláda, záťaž nezníži, iba presunie.[6]

Prevalencia vyhorenia sa medzi pracoviskami líši, a to je dobrá správa

Viacstredisková pilotná štúdia SUPERPOWER zisťovala vyhorenie u amerických školencov a lekárov v detskej nefrológii. Z 30 školencov a 86 lekárov z 11 pracovísk (návratnosť 85 %) spĺňalo kritériá vyhorenia **13 % školencov a 16 % lekárov**, teda podstatne menej, než sa v literatúre uvádza pre lekárov všeobecne.

Demografické a programové faktory s vyhorením nesúviseli. Súvisela s ním nižšia kvalita života, vyššia vnímaná záťaž stresom, nižšia spokojnosť s voľbou povolania a s rovnováhou medzi prácou a súkromím, a čo je pre riadenie najdôležitejšie, **nižšia inštitucionálna podpora programov starostlivosti o zamestnancov a nižšia spokojnosť s podporou zo strany kolegov**.[8]

Ide o pilotnú prácu s malou vzorkou, so zberom od februára do apríla 2020 a s obmedzením na detskú nefrológiu v Spojených štátoch; autori sami uvádzajú, že na potvrdenie nižšej prevalencie treba väčšie štúdie. Smer zistenia je napriek tomu užitočný. Ak sa prevalencia medzi pracoviskami líši a líši sa podľa toho, čo pracovisko robí, potom nejde o nemennú vlastnosť odboru, ale o niečo, čo sa dá riadiť.

Limity

- Všetky kvantitatívne merania pochádzajú zo Spojených štátov, z prostredia s odlišným financovaním, odlišnou administratívou poisťovní a odlišnými systémami dokumentácie. Absolútne čísla nie sú prenositeľné do slovenskej praxe.
- Prevažná väčšina údajov sa týka primárnej starostlivosti a niekoľkých vybraných odborov. Pre nefrológiu dospelých priame merania času stráveného dokumentáciou chýbajú.
- Všetky citované práce sú prierezové alebo observačné. Súvislosť medzi časom stráveným dokumentáciou, použiteľnosťou systému a vyhorením je asociáciou, nie dokázaným príčinným vzťahom, a obrátenú príčinnosť nemožno vylúčiť.
- Práca Toscana a kol. nedokázala zmerať prácu vykonanú doma, preto podiel práce po ambulancii podhodnocuje. Štúdia Sinského a kol. prebiehala v cielene vybraných, dobre fungujúcich ambulanciách, čo zovšeobecnenie obmedzuje opačným smerom.
- Odhad nákladov na náhradu lekára je americký, z roku 2018, a vychádza z modelových predpokladov. Ako kalkulácia pre slovenské pracovisko neplatí.
- Odporúčania v časti „Čo sa dá urobiť“ nie sú okrem merania a delegovania podložené intervenčnými štúdiami v nefrológii. Ide o organizačné opatrenia odvodené z povahy zistení.

Záver

Tvrdenie, že lekár strávi dokumentáciou a administratívou porovnateľný čas ako starostlivosťou o pacienta, nie je dojem. Je to opakovane zmeraný údaj, ku ktorému dospeli štyri práce s odlišnou metodikou, a jedna z nich svoje meranie overila priamym pozorovaním. Časť tejto práce sa systematicky presúva za hranicu pracovného dňa a tam sa spája s vyhorením, ktoré má pre pracovisko aj vyčísliteľnú ekonomickú cenu.

Riešenie však nie je „menej času pri počítači“. Údaje ukazujú, že časť času stráveného dokumentáciou zodpovedá skutočnej dôkladnosti a súvisí s lepšími ukazovateľmi kvality. Zmysluplný cieľ je preto užší a náročnejší: odobrať lekárovi to, čo nevyžaduje jeho kvalifikáciu, zlepšiť ovládateľnosť nástrojov a dať vybavovaniu správ miesto v pracovnom čase. V nefrológii, kde sa podstatná časť rozhodovania odohráva medzi návštevami a medzi pracoviskami, je táto úloha naliehavejšia než vo väčšine odborov, hoci práve pre ňu zatiaľ chýbajú vlastné merania.

Súvisiace články

- Lekári nežiadajú iba vyšší plat. Čoraz častejšie žiadajú späť kontrolu nad vlastným časom
- AI zapisovače a zdravotná dokumentácia: čo ukázalo kanadské hodnotenie
- eOČR v nefrologickej praxi: kompetencie, dokumentácia a najčastejšie chyby
- Umelá inteligencia v nefrológii: čo už vieme, kde sú limity a kam to smeruje
- Regulácia medicínskej umelej inteligencie: čo by mal lekár vedieť a čo z toho plynie pre nefrológiu

---

Text má odborný informačný charakter a je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani posúdenie miestnych organizačných a právnych podmienok. Uvedené americké údaje o financovaní, kompetenciách a nákladoch nie sú prenositeľné do slovenského prostredia bez overenia.

Odborné zdroje

1. Hochwald L. *Physicians Spend More Time on Paperwork Than With Patients: The Squeeze of Invisible Work.* Medscape Medical News, 21. októbra 2026. Plný text.
2. *Medscape State of the Medical Profession Index Report 2026.* Medscape Insights, 2026. Bez uvedeného individuálneho autora. Správa.
3. Berg S. *How much physician burnout is costing your organization.* American Medical Association, 11. októbra 2018. Plný text.
4. Arndt BG, Beasley JW, Watkinson MD, Temte JL, Tuan WJ, Sinsky CA, Gilchrist VJ. *Tethered to the EHR: Primary Care Physician Workload Assessment Using EHR Event Log Data and Time-Motion Observations.* Annals of Family Medicine. 2017;15(5):419 – 426. doi: 10.1370/afm.2121. PMID 28893811, PMCID PMC5593724. Plný text.

5. Toscano F, O'Donnell E, Broderick JE, May M, Tucker P, Unruh MA, Messina G, Casalino LP. *How Physicians Spend Their Work Time: an Ecological Momentary Assessment.* Journal of General Internal Medicine. 2020;35(11):3166 – 3172. doi: 10.1007/s11606-020-06087-4. PMID 32808212, PMCID PMC7661623. Plný text.
6. Melnick ER, Dyrbye LN, Sinsky CA, Trockel M, West CP, Nedelec L, Tutty MA, Shanafelt T. *The Association Between Perceived Electronic Health Record Usability and Professional Burnout Among US Physicians.* Mayo Clinic Proceedings. 2020;95(3):476 – 487. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.09.024. PMID 31735343.
7. Rotenstein LS, Holmgren AJ, Healey MJ, Horn DM, Ting DY, Lipsitz S, Salmasian H, Gitomer R, Bates DW. *Association Between Electronic Health Record Time and Quality of Care Metrics in Primary Care.* JAMA Network Open. 2022;5(10):e2237086. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.37086. PMID 36255725, PMCID PMC9579903. Plný text.
8. Halbach SM, Pillutla K, Seo-Mayer P, Schwartz A, Weidemann D, Mahan JD. *Burnout in Pediatric Nephrology Fellows and Faculty: Lessons From the Sustainable Pediatric Nephrology Workforce Project (SUPERPOWER).* Frontiers in Pediatrics. 2022;10:849370. doi: 10.3389/fped.2022.849370. PMID 35601419.
9. Sinsky C, Colligan L, Li L, Prgomet M, Reynolds S, Goeders L, Westbrook J, Tutty M, Blike G. *Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties.* Annals of Internal Medicine. 2016;165(11):753 – 760. doi: 10.7326/M16-0961. PMID 27595430.

Poznámka k dôkazovému základu: *Zdrojový text na portáli Medscape bol 30. októbra 2026 prečítaný v celom rozsahu vrátane mena autorky a dátumu vydania. Úplné autorské zoznamy, ročníky, čísla, strany a identifikátory DOI, PMID a PMCID všetkých šiestich odborných prác boli v ten istý deň overené cez PubMed a Crossref; všetky uvedené číselné hodnoty vrátane podielov času, pomeru šancí, intervalov spoľahlivosti a percentuálnych bodov pochádzajú zo štruktúrovaných abstraktov pôvodných prác. Odhad nákladov na náhradu lekára bol overený priamo na stránke Americkej lekárskej asociácie, kde je uvedený spolu s menom autorky a dátumom vydania. Predloha článku pripisovala tento odhad asociácii bez uvedenia autorky, ktorá na stránke uvedená je, a neuvádzala, že v samotnom zdrojovom texte ho vyslovil prezident organizácie The Physicians Foundation; obidve skutočnosti sú tu opravené. Práce Sinského a kol. (2016), Melnicka a kol. (2020), Rotensteina a kol. (2022) a Halbacha a kol. (2022) v predlohe neboli, boli vyhľadané a doplnené pri spracovaní, rovnako ako celá časť o vzťahu času stráveného dokumentáciou a ukazovateľov kvality, ktorá záver predlohy podstatne koriguje.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=administrativna-zataz-lekarov-dokumentacia-vyhorenie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.